

Trzy kryteria — *równie ważne*

Kryterium masy (A) nie jest najważniejsze. Kryterium B (lęk wagi) i C (zaburzony obraz ciała / brak wglądu) są równie kluczowe dla rozpoznania.

CZAS: 10-15 min **REALIZACJA:** wstępna ocena diagnostyczna

ŹRÓDŁO: APA (2022, DSM-5-TR); WHO (2022, ICD-11 kod 6B80); Walsh (2019, transitions in DSM-5)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy kryteria diagnostyczne** AN według DSM-5-TR: restrykcja → niska masa (A), lęk przed przytyciem (B), zaburzony obraz ciała lub brak wglądu (C). W sekcji 02 — **specyfikatory**: podtypy, ciężkość, remisja. Sekcja 03 — **różnice DSM-5-TR i ICD-11**. Sekcja 04 — implikacje kliniczne, kiedy konsultacja specjalistyczna.

DLACZEGO TO DZIAŁA

DSM-5-TR (APA, 2022) definiuje AN trzema kryteriami: **A** — restrykcja energii prowadząca do znacznie niskiej masy ciała w kontekście wieku, płci, rozwoju i zdrowia fizycznego; **B** — intensywny lęk przed przyrostem masy lub stałe zachowania utrudniające jej zdobywanie; **C** — zaburzenie sposobu doświadczania kształtu/masy ciała lub brak rozpoznania powagi obecnej niskiej masy. ICD-11 dodaje wyraźniej *waged-related cognitions*. Brak miesięczki został usunięty z DSM-5 — to było zbyt restrykcyjne (Attia i in., 2012).

01 Trzy kryteria DSM-5-TR — wszystkie muszą być spełnione

A · RESTRYKCJA → NISKA MASA
Istotnie niska masa w kontekście wieku, płci, trajektorii. Próg kliniczny: BMI < 18,5 (dorośli) lub < 5. percentyl (młodzież). *Nie* jest to „cel wagi” — jest progiem diagnostycznym.

B · LĘK PRZED PRZYTYCIEM
Intensywny lęk lub uporczywe zachowania uniemożliwiające przytycie — *nawet* przy znacznie niskiej masie. Paradoksalnie często *nasila się* w trakcie leczenia.

C · ZABURZONY OBRAZ CIAŁA
Nadwartościowanie wagi i kształtu w samoocenie *lub* uporczywy *brak wglądu* w powagę aktualnej masy. „Nie widzę problemu, mimo że inni są w panice”.

02 Specyfikatory DSM-5-TR + różnice ICD-11

SPECYFIKATOR	ZAWARTOŚĆ
Podtyp (3 mies.)	AN-R (restrykcyjny — bez napadów/kompensacji) lub AN-BP (z napadami i/lub kompensacjami). Patrz handout „Podtypy AN”.
Ciężkość (BMI)	Łagodna ≥ 17 ; umiarkowana 16–16,99; ciężka 15–15,99; ekstremalna < 15 . Ciężkość kliniczna może być wyższa niż wynikałaby z BMI, w zależności od objawów medycznych.
Remisja częściowa	Kryterium A (niska masa) nie jest spełnione — waga przywrócona, ale B (lęk wagi) lub C (zaburzony obraz ciała) nadal obecne.
Remisja pełna	Żadne kryterium nie jest spełnione przez znaczący okres czasu. Czas trwania nie jest sztywno określony.
ICD-11 (6B80)	Zbliżone do DSM-5-TR. Dodaje klasę „ <i>dangerously low body weight</i> ” (BMI < 14). Wyrażna kategoria „ <i>AN in recovery with normal body weight</i> ”. Podkategoria 6B80.Y dla atypowej AN.

03 Implikacje + kiedy konsultacja specjalistyczna

KTÓRE KRYTERIA U MNIE/BLISKIEJ OSOBY SĄ SPEŁNIONE

— A (niska masa) / B (lęk przed przytyciem) / C (zaburzony obraz ciała); zaznacz na podstawie obserwacji

SPECYFIKATORY

— podtyp (R / BP) na podstawie ostatnich 3 mies.; ciężkość; remisja, jeśli waga już przywrócona

SYGNAŁY DO PILNEJ KONSULTACJI

— omdlenia, kołatania, bradykardia, hipotensja, brak miesiączki
> 3 cykle, hipotermia, znaczące osłabienie

MÓJ PLAN — KTO, KIEDY, GDZIE

— lekarz pierwszego kontaktu / psychiatra / ośrodek ED; w razie sygnałów alarmowych — SOR

Klucz: kryterium A (niska masa) *nie* jest najważniejsze ani jedyne — kryteria B (lęk wagi) i C (zaburzony obraz ciała lub brak wglądu) są *równie kluczowe* dla rozpoznania AN. Pacjent z BMI nieznacznie powyżej progu klinicznego, ale ze wszystkimi pozostałymi objawami, wymaga oceny — szczególnie jeśli wcześniej tracił dużo masy (atypowa AN). DSM-5 (2013) usunął wymóg braku miesiączki (był obecny w DSM-IV), co rozszerzyło populację objętą diagnozą — w tym osoby przed pokwitaniem, mężczyźni i osoby przyjmujące hormonalne preparaty antykoncepcyjne (u których brak miesiączki nie jest sygnałem chorobowym). ICD-11 (2022) dodaje cenną kategorię „*AN w remisie z normalną masą*” — uznaje, że psychopatologia może utrzymywać się długo po normalizacji wagi. Klinicznie: *nie* ograniczaj diagnostyki do BMI — pytaj o myśli wagowe, lęk, obraz ciała, historię wagi.

⚠ Dla młodzieży kryterium A jest oceniane na podstawie percentyla BMI dla wieku i płci, nie dorosłego progu BMI 18,5. Spadek poniżej trajektorii rozwoju (np. nieuzyskanie oczekiwanej wagi) jest *równie poważny* jak utrata masy u dorosłych. Konsultacja pediatryczna lub psychiatryczna jest tu obowiązkowa. W Polsce — ośrodki specjalistyczne ED: konsultacja przez psychiatrę lub lekarza rodzinnego.